

PERJANJIAN KERJA SAMA LAYANAN KESEHATAN
antara
PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA
dengan
PT DISA PRIMA MEDIKA
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

No. Pihak Pertama: [●]

No. Pihak Kedua: [●]

Perjanjian Kerja Sama Layanan Kesehatan (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum di halaman penandatanganan, oleh dan antara:

- I. PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA**, suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di World Trade Centre 3 Lantai 10-15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta (untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**Pihak Pertama**"); dan
- II. ENDANG SUSILOWATI** sebagai Direktur Utama **PT. DISA PRIMA MEDIKA** didirikan berdasarkan Akta nomor 26, tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) 11 (November) 2009 (Dua Ribu Sembilan), dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 31 (Tiga Puluh Satu) 12 (Desember) 2009 (Dua Ribu Sembilan) serta yang telah diumumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Disa Prima Medika No. 10 tanggal 16 (Enam Belas) 10 (Oktober) 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, SH., Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit :
- A. **Rumah Sakit Prima Husada Malang** dengan izin operasional Rumah Sakit No.81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 diwakili oleh dr. Nur mazidah sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Banjararum Selatan No. 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
- B. **Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo** dengan Izin Operasional Rumah Sakit No 81201150810004 tertanggal 20 September 2023 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS. sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Raya Surabaya –Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo – Pasuruan (untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**Pihak Kedua**").

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Pertama adalah sebuah perusahaan asuransi jiwa patungan yang berkedudukan dan beroperasi di Indonesia yang memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa;
- Bahwa Pihak Kedua adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan berdasarkan ruang lingkup perizinan yang diberikan oleh instansi yang berwenang, termasuk bagi para Peserta yang mengikuti program asuransi kesehatan Pihak Pertama dan fasilitas kesehatan dari TPA;
- Bahwa Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Layanan Kesehatan Nomor Pihak Pertama 396/AZLI-LGL/AG/VI/2019 dan Nomor Pihak Kedua 240/RSPHS/E-PKS/DIR/V/2019 tertanggal 15 Juli 2019 dan/atau Perjanjian Penyediaan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Nomor Pihak Pertama [*] dan Nomor Pihak Kedua (apabila ada) tertanggal [*] (selanjutnya [/secara bersama-sama] disebut sebagai "**Perjanjian Awal**");
- Bahwa Para Pihak bermaksud untuk melanjutkan kerja sama namun dengan mengubah seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum pada Perjanjian Awal dan menyatakan kembali sehingga menjadi suatu perjanjian baru yang dibuat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
- Bahwa penyediaan fasilitas TPA telah/akan diadakan dan disediakan oleh Pihak Kedua sebelum/setelah ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak, karenanya segala ketentuan yang berkaitan dengan TPA berlaku mengikat dan sah bagi Para Pihak;

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pihak Pertama telah menunjuk Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dengan baik penunjukan tersebut dengan menyediakan dan menyelenggarakan layanan kesehatan kepada para Peserta (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Layanan Kesehatan**") sebagaimana diatur pada Lampiran; dan
- Pihak Pertama dengan ini menyetujui dan menerima untuk menanggung biaya yang timbul sehubungan dengan Layanan Kesehatan berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah disepakati secara bersama-sama oleh Para Pihak, kecuali dinyatakan sebaliknya pada Perjanjian ini.

Sehubungan dengan hal-hal yang disebutkan di atas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 ISTILAH

Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, seluruh istilah yang digunakan dalam Perjanjian ini termasuk seluruh lampirannya akan memiliki pengertian sebagai berikut:

Allianz-TPA	: Pihak Pertama yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai administrator penyedia tata kelola/pengelola Layanan Kesehatan Peserta, sebagaimana akan diinformasikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
TPA	: Administrator penyedia tata kelola/pengelola Layanan Kesehatan Peserta yang ditunjuk dan/atau disediakan oleh Pihak Pertama dan telah bekerja sama dengan Pihak Kedua.
Dokter	: Seorang sarjana ilmu kedokteran yang mempunyai kompetensi sebagai dokter dan telah memiliki izin-izin yang disyaratkan oleh instansi pemerintah yang berwenang untuk melakukan kegiatan praktek atau memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum.
Dokter Gigi	: Seorang sarjana ilmu kedokteran gigi yang mempunyai kompetensi sebagai dokter gigi dan telah memiliki izin-izin yang disyaratkan oleh instansi pemerintah yang berwenang untuk melakukan kegiatan praktek atau memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum.
Dokter Umum	: Seorang Dokter yang diperkenankan untuk melakukan praktik medis tanpa harus spesifik memiliki spesialisasi tertentu, hal ini memungkinkannya untuk memeriksa masalah-masalah kesehatan pasien secara umum untuk segala usia.
Dokter Spesialis	: Seorang Dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu.
Formulir Klaim	: Formulir yang disediakan oleh Pihak Pertama untuk diisi oleh Pihak Kedua yang disertai dengan tandatangan Peserta dan Dokter dan/atau Dokter Gigi untuk memperoleh penggantian biaya Layanan Kesehatan yang telah diterima dengan baik oleh Peserta sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
Kartu Peserta	: Kartu tanda kepesertaan program asuransi kesehatan, baik dalam bentuk fisik ataupun elektronik (<i>e-card</i>), yang diterbitkan oleh Allianz-TPA atau TPA kepada Peserta sebagai bukti yang sah atas hak kepesertaan untuk memperoleh Layanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
Layanan Kesehatan	: Semua Layanan Kesehatan yang disepakati dan disediakan oleh Pihak Kedua sebagaimana yang tercantum dalam Lingkup Layanan Kesehatan pada Lampiran.
Perlu Secara Medis	: Semua Layanan Kesehatan yang secara langsung terkait dengan kondisi medis Peserta, yang diperlukan untuk memulihkan kesehatan Peserta dan sejalan dengan diagnosis dan keadaan klinis Peserta, serta harus sesuai dengan standar medis. Layanan Kesehatan tersebut tidak boleh semata-

mata untuk memenuhi keinginan Peserta atau Dokter dan/atau Dokter Gigi yang merawatnya. Selain itu, Layanan Kesehatan harus dilakukan di tempat yang sesuai untuk pengobatan yang ekonomis dan efisien, tanpa bersifat percobaan atau eksperimen. Layanan Kesehatan ini juga harus memenuhi semua ketentuan sebagai berikut:

- a. Ditujukan untuk pengobatan langsung pada penyakit/luka;
- b. Tepat dan konsisten dengan keluhan, gejala, diagnosis dan pengobatan dari penyakit/luka;
- c. Dalam opini profesional dari seorang Dokter atau Dokter spesialis di bidang kesehatan yang relevan, adalah sepantasnya dan perawatan yang diberikan harus sejalan dengan praktek medis yang dapat diterima secara umum di Indonesia;
- d. Dalam hal Peserta perlu menjalani Rawat Inap, Penyakit/luka yang dialami oleh Peserta tidak dapat ditangani secara Rawat Jalan, dan mengharuskan dilakukannya Rawat Inap; dan
- e. Sesuai dengan standar praktik kedokteran yang berlaku di Indonesia, termasuk Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan dan Standar Pelayanan Medik yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Dalam hal masih terdapat perbedaan pendapat medis dari Para Pihak, maka dengan ini Para Pihak sepakat untuk mengacu kepada pendapat independen dari para Penasihat Medis, pendapat mana bersifat mutlak dan mengikat bagi Para Pihak.

Persalinan	: Layanan Kesehatan yang diberikan kepada Peserta yang ditujukan untuk melakukan proses kelahiran atau terminasi kehamilan secara wajar yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, berikut pemeriksaan lain yang menyertainya.
Telemedicine	: Layanan Rawat Jalan yang dilakukan secara daring oleh Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan/atau Dokter Gigi dengan menggunakan perantara aplikasi konferensi video untuk mendiagnosis, mengobati, mencegah, dan mengevaluasi kondisi kesehatan pasien. Telemedicine harus dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dari Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan/atau Dokter Gigi, yang dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi (STR) dengan tetap memperhatikan mutu layanan kesehatan yang diberikan dan keselamatan pasien.
Clinical Pathway	: Prosedur yang digunakan oleh tim medis untuk mengatur dan mengelola kualitas perawatan Kesehatan mengenai standarisasi proses perawatan.
Peserta	: Seseorang yang terdaftar pada Pihak Pertama yang berhak untuk menerima Layanan Kesehatan yang disediakan oleh Pihak Kedua. Setiap Peserta memiliki Kartu Peserta yang dikeluarkan secara bersama-sama oleh Pihak Pertama yang merupakan bukti sah kepesertaan yang ditunjukkan untuk memperoleh Layanan Kesehatan pada fasilitas kesehatan Pihak Kedua.
Penasihat Medis	: Dokter atau Dokter Gigi independen yang memiliki keahlian tertentu dan diakui di bidangnya masing-masing, yang ditunjuk oleh Pihak Pertama untuk memberikan pendapat medis apabila terjadi suatu perbedaan pendapat medis di antara Para Pihak, jika diperlukan.
Rawat Inap	: Layanan Kesehatan dan perawatan di Fasilitas Kesehatan akibat penyakit atau kecelakaan, yang direkomendasikan oleh Dokter di Fasilitas Kesehatan yang membutuhkan perawatan sekurang-kurangnya 6 (enam) jam sehingga menimbulkan biaya kamar perawatan.
Rawat Jalan	: Layanan Kesehatan yang diberikan kepada Peserta di mana Peserta tidak perlu mendapatkan perawatan Rawat Inap dari Pihak Kedua.
Fasilitas Kesehatan	: Rumah Sakit atau Klinik yang terdaftar atas nama Pihak Kedua sebagai pemiliknya yang sah dan berwenang untuk menyediakan serta menyelenggarakan jasa perawatan dan pengobatan medis, baik Rawat Inap dan/atau Rawat Jalan.

Rumah Sakit	: Penyedia Layanan Kesehatan yang sah dan berwenang untuk menyediakan serta menyelenggarakan jasa perawatan dan pengobatan medis bagi orang yang sakit dan/atau terluka: a. memiliki sarana untuk diagnosis dan tindakan bedah mayor atau operasi besar; b. menyediakan perawat yang berijazah dan terdaftar untuk memberikan perawatan 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari; c. menyediakan Layanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh para Dokter dan/atau Dokter Gigi yang memiliki izin praktek yang sah dan memiliki kompetensi; d. bukan semata-mata suatu klinik pengobatan tradisional, bukan tempat perawatan para pecandu alkohol atau obat bius, bukan panti asuhan, bukan rumah peristirahatan atau petirahan atau tempat pemulihan kesehatan sesudah sakit dan bukan sanatorium atau panti jompo atau badan usaha sejenis lainnya; e. memiliki izin penyelenggaraan Rumah Sakit yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Surat Rujukan	: Surat keterangan yang diterbitkan oleh suatu Rumah Sakit bagi Peserta sebagai pengantar untuk mendapatkan Layanan Kesehatan tingkat lanjutan di Fasilitas Kesehatan lainnya.
Tarif Yang Disepakati	: Tarif Layanan Kesehatan dan/atau Pemeriksaan yang telah disepakati oleh Para Pihak sebagaimana yang diuraikan dalam Lampiran.
Buku Tarif	: Tarif Layanan Kesehatan lainnya yang tidak disebutkan dalam Lampiran Perjanjian ini, yang diterbitkan oleh Pihak Kedua dan telah terlebih dahulu disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.
Unit Day Care	: Layanan Kesehatan yang tersedia pada Fasilitas Kesehatan Pihak Kedua, di mana Peserta mendapatkan perawatan medis dari Fasilitas Kesehatan berupa pengamatan/observasi klinis sekurang-kurangnya 6 (enam) jam tanpa memerlukan perawatan Rawat Inap.
Unit Gawat Darurat	: Layanan Kesehatan yang tersedia pada Fasilitas Kesehatan Pihak Kedua yang diperlukan Peserta untuk menyelamatkan jiwanya atau mencegah terjadinya cacat pada bagian tubuh, setelah Peserta mengalami kejadian tertentu yang memerlukan tindakan medis segera dan tidak dapat ditunda lagi atau setidaknya dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian tersebut.
BPJS Kesehatan	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Kartu BPJS Kesehatan	: Kartu peserta yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan yang wajib ditunjukkan ketika peserta tersebut akan mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan.
Peserta BPJS Kesehatan	: Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran jaminan kesehatan.
Peserta Koordinasi Manfaat	: Peserta yang mengikuti dirinya dan terdaftar sebagai Peserta di Pihak Pertama dan Peserta BPJS Kesehatan.
COB BPJS Kesehatan	: Suatu proses koordinasi manfaat yang terjadi ketika dua atau lebih penanggung (<i>payer</i>) yang memberikan perlindungan kesehatan kepada orang yang sama dan untuk manfaat kesehatan yang serupa, bersinergi untuk membatasi total manfaat yang diberikan hingga jumlah tertentu, agar total manfaat yang diberikan tidak melebihi biaya dari pelayanan kesehatan yang telah dibiayakan.
Peraturan Terkait COB BPJS Kesehatan	: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan beserta perubahan-perubahannya dan/atau panduan/pedoman dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai penerapan COB BPJS Kesehatan.

Informasi Rahasia : Setiap informasi, dan semua informasi yang diperoleh dari informasi tersebut, yang diterima dari Pihak pengungkap berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini (i) yang telah diberi label sebagai "informasi rahasia" atau serupa oleh Pihak pengungkap atau (ii) yang harus dianggap rahasia karena sifatnya atau keadaan pengungkapannya. Informasi berikut tidak dianggap sebagai Informasi Rahasia: Informasi yang (i) dikembangkan secara mandiri oleh Pihak penerima tanpa bantuan, penerapan atau penggunaan Informasi Rahasia, (ii) diungkapkan oleh pihak ketiga tanpa melanggar kewajiban kerahasiaan Pihak mana pun, (iii) telah atau menjadi tersedia secara umum untuk publik tanpa kesalahan atau pelanggaran dari Pihak penerima, atau (iv) Pihak penerima dapat menunjukkan bahwa ia telah memiliki informasi tersebut secara sah sebelum pengungkapan tanpa terikat oleh kewajiban kerahasiaan.

Mengingat lingkup dan kewenangan dari TPA dan Allianz TPA berbeda satu sama lain, Para Pihak setuju bahwa rujukan kepada "TPA atau Allianz-TPA" dalam Perjanjian ini harus diartikan sesuai dengan konteks dan kasus yang terjadi. Rujukan kepada "TPA atau Allianz-TPA" harus diartikan sebagai rujukan hanya terhadap TPA jika konteks dan kasusnya menentukan demikian; begitupula rujukan kepada "TPA atau Allianz-TPA" harus diartikan sebagai rujukan hanya terhadap Allianz-TPA jika konteks dan kasusnya menentukan demikian.

Pasal 2

LINGKUP LAYANAN

- (1) Pihak Kedua akan menyediakan Layanan Kesehatan untuk Peserta sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran.
- (2) Penambahan dan/atau pembatasan Layanan Kesehatan dalam situasi tertentu akan diatur melalui kesepakatan Para Pihak yang akan dituangkan secara tertulis dan dilampirkan sebagai tambahan (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Lampiran**"). Lampiran ini akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Selain hak-hak lainnya yang diatur dalam Perjanjian ini, hak-hak Pihak Pertama adalah sebagai berikut:
 - i. Mendapatkan jasa Layanan Kesehatan terbaik dari Pihak Kedua bagi para Peserta program asuransi kesehatan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
 - ii. Menunjuk dan/atau sewaktu-waktu mengubah pengelola Layanan Kesehatan yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua.
 - iii. Menunjuk Penasihat Medis untuk menentukan apakah suatu Pelayanan Kesehatan Perlu Secara Medis atau tidak.
 - iv. Menolak perubahan Tarif Yang Disepakati yang tidak dilakukan sesuai dengan Perjanjian ini dan/atau perubahan tarif yang dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
 - v. Menolak untuk membayar setiap biaya tagihan Layanan Kesehatan yang diajukan oleh Pihak Kedua atas diri Peserta jika: i) tidak Perlu Secara Medis; ii) tidak tercantum dalam, atau tidak sesuai dengan, Buku Tarif dan/atau Tarif Yang Disepakati; dan iii) tidak sesuai dengan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini.
 - vi. Melakukan peninjauan/pengkajian secara berkala atas pelaksanaan Perjanjian ini (termasuk kinerja Pihak Kedua dan/atau Fasilitas Kesehatan) dan memberikan rekomendasi dari hasil peninjauan/pengkajian berkala kepada Pihak Kedua.
 - vii. Memberlakukan pembatasan bagi Peserta untuk melakukan Layanan Kesehatan pada Pihak Kedua dengan fasilitas *cashless* dan/atau *reimbursement* berdasarkan hasil peninjauan/pengkajian secara berkala pada Pasal 3 Ayat (1) poin (vi).
 - viii. Mengakhiri Perjanjian ini dengan mengikuti ketentuan Pasal 9 Perjanjian ini.
 - ix. Melakukan pemantauan harian (*case monitoring*) terhadap perawatan Peserta melalui pihak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama ("**Pemantauan Harian**"). Dalam hal ini, Pihak Kedua diharuskan untuk memberikan informasi sehubungan dengan tagihan harian dan perkembangan kondisi medis Peserta yang sedang menjalani perawatan.
- (2) Selain kewajiban-kewajiban lainnya yang diatur dalam Perjanjian ini, kewajiban-kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut:
 - a. Menerbitkan Kartu Peserta yang akan dipergunakan oleh setiap Peserta untuk membuktikan identitas, berlakunya kepesertaan dan hak atas layanan kesehatan Peserta kepada Pihak Kedua.
 - b. Membayar biaya tagihan Layanan Kesehatan yang diajukan oleh Pihak Kedua atas diri Peserta yang telah memenuhi seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian ini.

- c. Memberikan konfirmasi kepesertaan untuk kasus Rawat Inap atas diri Peserta, serta memberikan persetujuan Rawat Inap.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

Selain hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya yang diatur dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban Pihak Kedua adalah sebagaimana diatur pada Lampiran.

Pasal 5 **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Masing-masing Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan dan menjamin (yang mana yang sesuai) bahwa:

- (1) Masing-masing Pihak adalah subjek hukum yang sah dan diakui di hadapan hukum, dan dokumen-dokumen yang diserahkan adalah sah dan benar adanya.
- (2) Masing-masing Pihak mempunyai hak, kekuasaan, kapasitas hukum dan kewenangan penuh untuk menandatangani, menyerahkan, dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan tidak ada persetujuan, izin atau pelepasan hak dari pihak ketiga atau otoritas pemerintah yang berwenang yang belum atau perlu diperoleh untuk menandatangani dan menjalankan Perjanjian ini.
- (3) Seluruh dokumen yang ditandatangani oleh Para Pihak yang berkaitan dengan Perjanjian ini adalah sah dan mengikat bagi Para Pihak karenanya, menimbulkan suatu kewajiban dan paksaan bagi Para Pihak.
- (4) Masing-masing Pihak menjamin memiliki perijinan operasional usaha masing-masing Pihak dan perijinan operasional tersebut akan terus dipertahankan masa berlakunya selama berlakunya Perjanjian ini. Kegagalan memenuhi atau mempertahankan keberlakuan perijinan yang dimaksud memberikan hak kepada Pihak lainnya untuk sewaktu-waktu mengakhiri Perjanjian ini secara otomatis.
- (5) Pihak Pertama telah mendapatkan kuasa dari Peserta untuk mendapatkan informasi kesehatan Peserta, yaitu termasuk, namun tidak terbatas pada, salinan hasil pemeriksaan, keterangan medis, ringkasan catatan medis dan informasi kesehatan lainnya yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama dalam memproses klaim Peserta.
- (6) Salinan informasi kesehatan, yaitu termasuk, namun tidak terbatas pada, salinan hasil pemeriksaan, keterangan medis, ringkasan catatan medis dan informasi kesehatan lainnya yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama dalam memproses klaim Peserta, yang dibagikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan Pihak Kedua.
- (7) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin timbul akibat ketidakbenaran pernyataan dan jaminan yang diberikan olehnya, termasuk namun tidak terbatas atas setiap kegagalan dalam memenuhi dan/atau melengkapi dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan dalam pembuatan, penandatanganan maupun pelaksanaan Perjanjian ini.
- (8) Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Para Pihak akan selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini maupun yang akan datang.

Pasal 6 **BIAYA-BIAYA LAYANAN KESEHATAN**

- (1) Biaya Layanan Kesehatan yang diberikan Pihak Kedua wajib mengacu pada Tarif Yang Disepakati sebagaimana yang diuraikan pada Lampiran Perjanjian ini, atau pada Buku Tarif yang telah disepakati bersama-sama oleh Para Pihak.
- (2) Pihak Kedua tidak akan mengenakan biaya apapun terhadap Peserta selain terhadap hal-hal yang telah disepakati dan/atau ditentukan Perjanjian ini.
- (3) Setiap perubahan Tarif Yang Disepakati dan/atau Buku Tarif harus terlebih dahulu diberitahukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemberlakuan tarif baru tersebut kepada Pihak Pertama untuk mendapatkan persetujuan. Atas perubahan Tarif Yang Disepakati dan/atau Buku Tarif tersebut, Para Pihak sepakat untuk menerima perubahan tanpa harus terlebih dahulu dibuat dan dituangkan dalam suatu addendum Perjanjian ini sepanjang perubahan tersebut telah dibuat secara

tertulis, disepakati dan diterima dengan baik oleh Para Pihak. Tarif baru tersebut tidak dapat berlaku surut.

- (4) Dalam hal Pihak Kedua memberikan potongan harga (diskon) atas Layanan Kesehatan, maka ketentuan potongan harga diatur pada Lampiran.

Pasal 7 PEMBAYARAN KLAIM

- (1) Pembayaran klaim akan dilakukan oleh Pihak Pertama setelah Pihak Kedua memenuhi tata cara penagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dengan proses pemindahbukuan bank (*bank transfer*) ke rekening Pihak Kedua sebagaimana tercantum di Lampiran.
- (2) Setiap perubahan rekening Bank harus diberitahukan kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diberlakukannya nomor rekening yang baru.
- (3) Pihak Pertama akan memotong Pajak Penghasilan Pihak Kedua sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- (4) Pihak Kedua dengan ini bertanggung jawab atas segala keterangan mengenai rekening bank sebagaimana diatur dalam Ayat 1 Pasal ini dan rekening tersebut adalah sah dan benar milik Pihak Kedua, serta membebaskan Pihak Pertama atas segala tanggung jawab hukum dan lainnya yang timbul akibat ketidakbenaran rekening bank tersebut.
- (5) Rekonsiliasi tagihan pembayaran klaim:
 - a. Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan melakukan rekonsiliasi tagihan klaim dan pembayarannya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
 - b. Pihak Kedua akan memberikan rincian rekonsiliasi yang memuat sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - i. Data rincian tagihan klaim, sebagai berikut:
 - Tanggal lahir Peserta;
 - Jenis kelamin Peserta;
 - Tanggal perawatan (termasuk tanggal masuk dan tanggal keluar);
 - Total tagihan; dan
 - Nomor Kartu Peserta.
 - ii. Data rincian tagihan klaim yang sudah dibayarkan oleh Pihak Pertama.
 - iii. Data rincian tagihan klaim yang belum dibayarkan oleh Pihak Pertama.
 - iv. Kelebihan pembayaran (jika ada).
 - v. Kekurangan pembayaran (jika ada).
 - c. Pihak Pertama akan melakukan pemeriksaan atas data yang diberikan oleh Pihak Kedua dan wajib memberikan konfirmasi, tanggapan, dan/atau koreksi secara tertulis atas data tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak data diberikan.
 - d. Atas konfirmasi, tanggapan dan/atau koreksi, maka Pihak Kedua wajib melakukan pemeriksaan kembali dan melakukan diskusi dengan Pihak Pertama (sebagaimana dianggap diperlukan) dan menyelesaikan permasalahan mengenai konfirmasi, tanggapan dan/atau koreksi atas data selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak konfirmasi, tanggapan dan/atau koreksi disampaikan oleh Pihak Pertama.
 - e. Dalam hal terdapat lebih bayar dan/atau kurang bayar, maka:
 - (i) Lebih bayar: kelebihan pembayaran akan dikurangkan pada tagihan selanjutnya (set-off).
 - (ii) Kurang bayar: kekurangan pembayaran akan ditagihkan kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama wajib melakukan pembayaran sekurang-kurangnya 21 hari kerja sejak kesepakatan data rekonsiliasi.
 - f. Pengajuan rekonsiliasi tagihan pembayaran klaim oleh Pihak Kedua hanya dapat dilakukan atas Peserta yang selesai menjalani Layanan Kesehatan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelumnya di Fasilitas Kesehatan Pihak Kedua. Apabila lebih dari periode tersebut, Pihak Pertama tidak dapat memproses pengajuan rekonsiliasi tagihan pembayaran klaim dan Pihak Pertama dibebaskan dari kewajiban pembayaran tagihan klaim tersebut.
- (6) Selain dari hak dan upaya hukum lainnya yang tersedia bagi Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini dan/atau hukum yang berlaku, Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari tanggung jawab pembayaran klaim yang ditagihkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini apabila Pihak Kedua:
 - a. melanggar suatu ketentuan dalam Perjanjian ini; dan/atau
 - b. lalai atau melakukan setiap kesalahan (termasuk tetapi tidak terbatas pada kesalahan atau kelalaian dalam menghitung biaya Rawat Jalan dan/atau Rawat Inap) yang menyebabkan:
 - (i) tidak ditagihkannya eksekusi klaim kepada Peserta;

- (ii) tidak dibayarkannya eksekusi klaim secara langsung oleh Peserta kepada Pihak Kedua; dan/atau
- (iii) terjadinya ketidaksesuaian antara jumlah klaim yang sudah disetujui oleh Pihak Pertama dengan jumlah biaya Rawat Jalan dan/atau Rawat Inap yang ditagih oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

Pasal 8 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, komunikasi dan koordinasi formal yang harus disampaikan oleh masing-masing Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini, wajib diberitahukan dan disampaikan secara tertulis melalui alamat-alamat sebagaimana tercantum di Lampiran.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, maka Pihak yang mengubah alamat korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat korespondensi dimaksud tersebut berlaku. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-surat atau pemberitahuan-pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir internal yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing Pihak.
- (3) Segala akibat yang timbul dari kegagalan untuk memberitahukan Pihak lain mengenai perubahan alamat di atas akan menjadi risiko dan tanggung jawab Pihak yang mengubah alamat.

Pasal 9 MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal Perjanjian ini untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan dapat diakhiri dengan pemberitahuan tertulis sesuai dengan ketentuan Ayat 2 Pasal ini.
- (2) Masing-masing Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan cara mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian.
- (3) Perjanjian ini dapat dengan segera diakhiri oleh salah satu Pihak, dalam hal:
 - (a) Pihak Pertama atau Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban dalam Perjanjian ini dan tidak memperbaikinya atau tidak melakukan tindakan pemulihan setelah diberikan 2 (dua) kali surat peringatan dari Pihak yang dirugikan dengan jangka waktu masing-masing surat peringatan adalah 30 (tiga puluh) hari;
 - (b) Ijin Usaha atau ijin operasional salah satu Pihak dicabut oleh pemerintah;
 - (c) Salah satu Pihak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - (d) Harta kekayaan salah satu Pihak disita, baik sebagian maupun seluruhnya dan menjadi objek suatu perkara yang menurut pendapat Pihak lainnya dapat mempengaruhi kemampuan Pihak tersebut untuk melaksanakan kewajibannya yang timbul dari Perjanjian; atau
 - (e) Diminta oleh pemerintah (termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan atau pihak yang berwenang lainnya) untuk mengakhiri atau membatalkan Perjanjian ini
- (4) Jika ada kewajiban yang belum diselesaikan oleh Para Pihak pada saat pengakhiran Perjanjian ini, maka Para Pihak wajib menyelesaikan kewajibannya dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya Perjanjian ini. Pihak Kedua wajib menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen-dokumen terkait Perjanjian ini.
- (5) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai persyaratan pemutusan Perjanjian dengan putusan atau perintah dari suatu badan peradilan.

Pasal 10 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud force majeure dalam Perjanjian ini adalah suatu peristiwa di luar kemampuan Para Pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini oleh salah satu Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, angin puyuh, tanah longsor, kebakaran, ledakan, bencana alam, perang, kerusakan, terorisme, perebutan kekuasaan, sabotase, embargo, mogok kerja masal, perubahan drastis politik/ekonomi, yang dikuatkan ataupun tidak oleh pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu.

- (2) Dalam hal force majeure mempengaruhi kemampuan pelaksanaan salah satu Pihak dalam melaksanakan Perjanjian, Pihak yang mengalami force majeure tersebut wajib memberitahukan dan menjelaskan pada Pihak lainnya mengenai force majeure tersebut, akibatnya terhadap kemampuan Pihak yang terkena force majeure untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan perkiraan jangka waktu dari terjadinya force majeure sampai dengan tanggal pelaksanaan kembali dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah force majeure terjadi.
- (3) Apabila Pihak yang mengalami force majeure lalai atau sengaja untuk tidak melaporkan kepada Pihak lain akan kejadian force majeure yang menimpanya, maka Pihak yang mengalami force majeure berkewajiban untuk menanggung semua kerugian, risiko dan konsekuensi yang timbul karena ketidakmampuan untuk melaksanakan Perjanjian ini sampai dengan tanggal pemberitahuan dari Pihak yang mengalami force majeure kepada Pihak lainnya.
- (4) Para Pihak tidak saling bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban yang dikarenakan force majeure, sebatas pihak yang terkena dampak daripada force majeure telah berusaha sebaik-baiknya untuk terhindar dari force majeure dan telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya sesuai dengan jangka waktu yang disebutkan dalam ayat (2) Pasal ini.
- (5) Force majeure tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk tidak melakukan pembayaran, akan tetapi pembayaran tersebut dapat ditunda, dengan ketentuan bahwa penundaan tersebut tidak menimbulkan biaya tambahan, denda, pengurangan hak atau pembebasan atas kewajiban.

Pasal 11 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan, kontroversi atau pertikaian yang berkaitan dengan Perjanjian ini dan pelaksanaan dan/atau tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian ini sedapat mungkin akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.
- (2) Semua perselisihan atau kontroversi yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan tersebut diajukan secara tertulis oleh salah satu Pihak kepada Pihak lain, harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 12 **KEPATUHAN TERHADAP HUKUM ANTI-PENYUAPAN**

- (1) Para Pihak tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan setiap tindakan sehubungan dengan negosiasi, keputusan, atau pelaksanaan dari Perjanjian ini yang akan menyebabkan Para Pihak dan/atau afiliasinya menjadi melakukan pelanggaran terhadap segala hukum atau perundang-undangan tentang anti-korupsi atau anti-penyuapan yang berlaku. Kewajiban ini berlaku khususnya untuk pembayaran yang tidak sah termasuk memfasilitasikan pembayaran kepada pejabat pemerintah, perwakilan dari otoritas publik atau rekan-rekan, keluarga, atau teman-teman dekat mereka.
- (2) Masing-masing Pihak setuju untuk tidak akan menawarkan atau memberi, atau setuju untuk memberi, kepada setiap karyawan, perwakilan, atau pihak ketiga yang bertindak atas nama Pihak lain atau menerima, atau menyetujui untuk menerima dari setiap karyawan, perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama Pihak lain, hadiah atau manfaat yang tidak wajar, baik berupa uang atau lainnya sehubungan dengan negosiasi, keputusan, atau pelaksanaan dari Perjanjian ini.
- (3) Masing-masing Pihak harus segera memberitahukan Pihak lainnya, jika menyadari atau memiliki kecurigaan khusus adanya korupsi berkaitan dengan negosiasi, keputusan atau pelaksanaan dari Perjanjian ini.
- (4) Apabila terdapat pembayaran atau pemberian hadiah yang tidak wajar sehubungan dengan negosiasi, keputusan, atau pelaksanaan dari Perjanjian ini yang dilakukan oleh salah satu Pihak yang telah melanggar klausul ini, atau jika salah satu Pihak memiliki alasan untuk meyakini bahwa pembayaran atau pemberian hadiah tersebut telah dilakukan, maka Pihak tersebut dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan seketika. Apabila Pihak Pertama memiliki bukti bahwa Pihak Kedua secara langsung atau tidak langsung telah menyuap atau memberikan hadiah atau manfaat yang tidak wajar sehubungan dengan negosiasi, keputusan atau pelaksanaan dari Perjanjian ini kepada karyawan atau perwakilan Pihak Pertama (termasuk anggota keluarganya, teman dekatnya dan/atau afiliasinya), maka Pihak Pertama berhak untuk menahan, memotong atau menarik kembali semua fee atau jumlah lainnya yang sudah dibayarkan kepada Pihak Kedua dan tidak memiliki kewajiban lebih lanjut untuk membayar fee atau jumlah lainnya yang akan jatuh tempo kepada Pihak Kedua sekarang atau di kemudian hari.

Pasal 13 LAIN-LAIN

(1) Kerahasiaan:

- a. Semua Informasi Rahasia hanya akan digunakan untuk tujuan melaksanakan hak atau untuk mematuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini. Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk jangka waktu yang tidak terbatas akan melindungi Informasi Rahasia tersebut dari penggunaan atau pengungkapan yang tidak sah (disengaja, tidak sengaja, atau lainnya) dan, dalam hal apa pun, akan memberlakukan setidaknya tingkat kehati-hatian yang sama seperti yang digunakannya untuk melindungi informasinya sendiri yang sifatnya serupa untuk menghindari penggunaan atau pengungkapan yang tidak sah.
- b. Meskipun dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, setiap Pihak penerima (i) dapat mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak yang mengungkapkan; dan (ii) dapat mengungkapkan Informasi Rahasia tanpa persetujuan dari Pihak yang mengungkapkan atas dasar *need-to-know basis*:
 - (i) sejauh yang dipersyaratkan oleh hukum wajib dan/atau otoritas pengatur dan asalkan Pihak penerima, jika diizinkan secara hukum, segera memberi tahu Pihak pengungkap secara tertulis tentang kewajiban tersebut, dan
 - (ii) kepada salah satu karyawan, kontraktor, subkontraktor, agen, dan pihak ketiga lainnya yang dipekerjakan oleh suatu Pihak atau bertindak atas nama suatu Pihak ("**Personil**") dengan ketentuan bahwa Pihak penerima bertanggung jawab atas kepatuhan Personil tersebut terhadap kewajiban kerahasiaan dalam Perjanjian ini, dan kepada penasihat profesional yang memiliki kewajiban kerahasiaan berdasarkan undang-undang yang berlaku atau secara tegas diwajibkan untuk tunduk pada kewajiban kerahasiaan.Selain hal tersebut di atas, Pihak Pertama berhak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia atas dasar *need-to-know basis* kepada salah satu Afiliasinya.
- c. Setelah selesainya Jasa atau pengakhiran Perjanjian ini (mana yang paling awal), Pihak penerima setiap Informasi Rahasia yang berwujud, termasuk dokumen, kontrak, catatan, atau properti, akan mengembalikan barang tersebut dan setiap salinannya ke Pihak pengungkap dalam waktu 14 hari sejak diterimanya permintaan tertulis dari Pihak pengungkap, dan/atau, atas kebijaksanaan Pihak pengungkap, memusnahkannya dan setiap salinannya dan memberikan konfirmasi tertulis yang sesuai kepada Pihak pengungkap, kecuali jika retensi Informasi Rahasia tersebut diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku.
- d. Setiap Pihak setuju untuk:
 - (i) melindungi Informasi Rahasia Pihak lainnya dengan tingkat kehati-hatian yang sama yang digunakannya untuk melindungi Informasi Rahasiannya sendiri dengan sifat yang sama, dengan ketentuan bahwa tingkat kehati-hatian yang digunakan tidak boleh kurang dari tingkat kehati-hatian yang wajar; dan
 - (ii) menerapkan langkah-langkah teknis, fisik, dan organisasional yang wajar dan sesuai untuk melindungi Informasi Rahasia terhadap akses, penggunaan, perubahan, pengungkapan, kerusakan, penghancuran, atau kehilangan yang tidak disengaja atau tidak sah, dan yang akan memberikan setidaknya tingkat keamanan yang wajar yang sesuai terhadap risiko atas kepemilikan, pemrosesan, dan sifat Informasi Rahasia yang akan dilindungi. Tindakan tersebut harus mematuhi undang-undang, peraturan, regulasi, dan perintah dari otoritas pemerintah mana pun yang memiliki yurisdiksi terkait, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan undang-undang perlindungan data apa yang berlaku.
- e. Setelah mengetahui adanya pelanggaran atau potensi adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal ini, masing-masing Pihak harus:
 - (i) segera memberi tahu Pihak lainnya, dengan perincian yang memadai agar Pihak lainnya mematuhi kewajibannya terkait dengan Informasi Rahasia yang relevan dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau meminimalkan kerugian atau kerusakan yang mungkin diakibatkan oleh pelanggaran tersebut; dan
 - (ii) bekerja sama sepenuhnya, segera dan dengan itikad baik sebagaimana diminta oleh Pihak lainnya dalam menginvestigasi dan menangani setiap insiden tersebut, dan harus memastikan bahwa Personil kunci dengan pengetahuan yang memadai tersedia untuk bekerja dengan Pihak lainnya guna menyelesaikan masalah privasi atau keamanan data dan untuk menyelidiki dan menyiapkan ringkasan tertulis dari insiden tersebut dan tindakan korektif yang diambil.
- f. Semua Informasi Rahasia adalah dan akan tetap menjadi satu-satunya milik Pihak yang memiliki Informasi Rahasia tersebut, dan Pihak penerima tidak akan memperoleh hak atau lisensi apa pun sehubungan dengan Informasi Rahasia tersebut kecuali sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian ini.
- g. Masing-masing Pihak setuju bahwa ia akan bertanggung jawab atas tindakan atau ketiadaan tindakan Personilnya yang menyebabkan atau mengakibatkan pelanggaran terhadap Pasal ini

seolah-olah tindakan atau ketiadaan tindakan tersebut adalah tindakan atau ketiadaan tindakan Pihak itu sendiri.

- h. Hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran Perjanjian ini.

(2) Perubahan TPA

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan TPA yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dan TPA tersebut telah bekerja sama dengan Pihak Pertama, maka Para Pihak sepakat bahwa penambahan dan/atau perubahan TPA akan diberitahukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalendar sebelum tanggal efektif penambahan dan/atau perubahan TPA dengan ketentuan surat pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya memuat mengenai:

- a. Nama badan hukum TPA
- b. Alamat badan hukum TPA
- c. Korespondensi badan hukum TPA (termasuk alamat penyampaian tagihan klaim untuk penjaminan melalui TPA, email, telepon, faksimili, dan PIC).

(3) Audit

Para Pihak setuju untuk memberikan kerja sama yang baik untuk setiap proses audit yang dilakukan oleh pihak yang sah, termasuk namun tidak terbatas kepada proses audit yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK dalam rangka untuk memperoleh catatan dan dokumen transaksi apapun, untuk setiap transaksi berdasarkan Perjanjian ini dan perubahannya (jika ada) dan akan menyediakan informasi untuk tujuan audit tersebut termasuk hak akses kepada data yang dikelola oleh Para Pihak.

- (4) Perjanjian ini dibuat dan ditafsirkan dan dilaksanakan menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- (5) Masing-masing Pihak wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalendar dalam hal terdapat perubahan pada proses pemberian Layanan Kesehatan yang berdampak pada pelaksanaan Perjanjian ini.

- (6) Setiap perubahan atau penambahan pada Perjanjian ini akan dirundingkan secara musyawarah oleh Para Pihak dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan dari dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (7) Kecuali disetujui sebaliknya secara tertulis oleh Pihak lainnya, masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan, baik secara sebagian atau keseluruhan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga.

- (8) Lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.

- (9) Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian.

- (10) Syarat dan ketentuan pada Perjanjian ini merupakan seluruh kesepakatan Para Pihak. Perjanjian ini menggantikan dan mengakhiri seluruh janji, pernyataan, perjanjian, dan kesepakatan sebelumnya, baik lisan maupun tertulis antara Para Pihak.

- (11) Setiap Pihak tidak akan dianggap telah menyampingkan suatu hak, kewenangan atau hak istimewa yang dimilikinya berdasarkan Perjanjian ini atau suatu bagian dari padanya kecuali bilamana penyimpangan semacam itu telah dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pihak yang bersangkutan. Dalam hal suatu Pihak, pada suatu ketika, gagal melaksanakan ketentuan-ketentuan dan Perjanjian ini maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan Perjanjian ini atau suatu bagian dari padanya atau hak Pihak tersebut untuk selanjutnya melaksanakan masing-masing dan setiap ketentuan dan hak tersebut. Penyimpangan atas suatu kegagalan pelaksanaan salah satu ketentuan Perjanjian ini tidak diartikan sebagai penyimpangan atas kegagalan pelaksanaan ketentuan tersebut di kemudian hari ataupun kegagalan pelaksanaan persyaratan lainnya.

- (12) Tidak ada hal apapun dalam Perjanjian ini yang boleh dianggap untuk ditafsirkan sehingga menjadikan salah satu Pihak sebagai agen atau kuasa dari Pihak lainnya.

- (13) Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa rangkap, dan penandatanganan tersebut akan mempunyai akibat hukum yang sama seperti halnya jika semua tanda tangan dalam rangkap-rangkap tersebut dibuat dalam satu salinan Perjanjian ini. Tanpa membatasi ketentuan sebelumnya, apabila tanda tangan suatu pihak terdapat dalam rangkap yang berbeda, hal tersebut harus dianggap

bahwa, dan akan mempunyai akibat hukum yang sama seperti halnya jika, tanda tangan tersebut ada dalam rangkap yang sama dan dalam satu salinan Perjanjian ini. Setiap rangkap ketika ditandatangani merupakan suatu dokumen asli dan semua rangkap yang ada merupakan satu instrumen yang sama. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan pelaksanaannya (sebagaimana yang dapat diubah dan digantikan dari waktu ke waktu) ("**UU ITE**"), Para Pihak mengakui dan menyetujui bahwa Perjanjian ini dapat ditandatangani dengan tanda tangan elektronik (baik seluruhnya atau sebagian), yang harus dianggap sebagai tanda tangan asli untuk semua tujuan dan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan asli (basah). Perjanjian ini yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik tersebut sesuai dengan UU ITE tersebut akan mengikat Para Pihak sama halnya jika Perjanjian ini ditandatangani secara fisik dan masing-masing Pihak dengan ini menyetujui atas penggunaan setiap pihak ketiga penyedia jasa tanda tangan elektronik tersertifikasi sebagaimana yang dapat dipilih oleh setiap Pihak. Para Pihak mengakui dan menyetujui bahwa, dalam setiap proses hukum di antara mereka dalam setiap hal yang sehubungan dengan Perjanjian ini, masing-masing Pihak secara tegas mengesampingkan setiap haknya untuk (i) mengajukan pembelaan atau pelepasan tanggung jawab/kewajiban; dan/atau (ii) membatalkan Perjanjian ini, atas alasan penandatanganan Perjanjian ini oleh suatu Pihak dengan tanda tangan elektronik.

(14) Pihak Kedua menegaskan bahwa Pihak Kedua telah membaca dan memahami Kode Etik Pihak Pertama (yang dapat diakses secara bebas di <https://www.allianz.co.id/tentang-kami/kode-etik-allianz.html>). Pihak Kedua menjamin kepada Pihak Pertama bahwa Pihak Kedua akan mematuhi Kode Etik Pihak Pertama dan tidak akan melakukan suatu hal yang bertentangan dengan Kode Etik Pihak Pertama.

(15) Tanggal Perjanjian ini adalah tanggal terakhir penandatanganan.

Perjanjian ini dibuat pada tanggal sebagaimana disebutkan pada halaman penandatanganan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing Pihak.

PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

**PT DISA PRIMA MEDIKA
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA**

Heng Teik Boon
Chief Technical Officer

ENDANG SUSILOWATI
Direktur Utama

LAMPIRAN 1
LAYANAN KESEHATAN

Daftar Isi Lampiran 1		
Lampiran 1A	:	Lingkup Layanan Kesehatan dan Pengecualian
Lampiran 1B	:	Hak dan Kewajiban Pihak Kedua (Rawat Jalan dan Rawat Inap)
Lampiran 1C	:	Tata Cara Penerimaan Pasien (Rawat Jalan dan Rawat Inap)
Lampiran 1D	:	Tarif Yang Disepakati dan Rekening Bank
Lampiran 1E	:	Korespondensi dan Pengiriman Dokumen Penagihan

LAMPIRAN 1A
LINGKUP LAYANAN KESEHATAN DAN PENGECUALIAN

I. KETENTUAN UMUM

- (1) Lingkup Layanan Kesehatan yang merupakan hak Peserta dalam program asuransi kesehatan, baik dalam konteks peserta grup/perusahaan maupun individu, adalah sebagaimana tercantum pada Kartu Peserta atau lembar konfirmasi kepesertaan yang diterbitkan oleh TPA atau Allianz-TPA melalui platform TPA atau Allianz-TPA.
- (2) Pihak Kedua wajib untuk mematuhi seluruh ketentuan Pengecualian atas Layanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini, yang akan diperbaharui dari waktu ke waktu oleh Pihak Pertama dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu.
- (3) Pada keadaan gawat darurat, penyakit atau kecelakaan yang tiba-tiba dan serius, dan/atau untuk kasus-kasus yang terjadi pada hari libur, maka Layanan Kesehatan dapat disediakan oleh Pihak Kedua melalui Unit Gawat Darurat.
- (4) Pelaksanaan Layanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua harus tetap memperhatikan pengecualian-pengecualian sebagaimana disepakati oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini.
- (5) Pihak Pertama berhak menolak seluruh pembayaran biaya Layanan Kesehatan yang (i) tidak Perlu Secara Medis; (ii) tidak sesuai dengan Tarif Yang Disepakati atau Buku Tarif; dan/atau (iii) tidak sesuai dengan kesepakatan Para Pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (6) Jika Layanan Kesehatan yang diberikan termasuk pemberian obat kepada Peserta, maka Para Pihak setuju bahwa (i) harga obat yang diberikan kepada Peserta harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat (termasuk setiap perubahan atau pengganti dari peraturan tersebut); dan (ii) harga obat yang diberikan kepada Peserta tidak boleh lebih tinggi daripada harga yang diberikan oleh apotek Pihak Kedua kepada pasien umum (non-asuransi). Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, selain dari hak-hak Pihak Pertama yang diatur dalam Perjanjian ini, Pihak Pertama berhak untuk, terkait dengan obat yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Peserta, membayar Pihak Kedua sebesar, mana yang lebih kecil, Harga Eceran Tertinggi (HET) dari obat tersebut, atau harga obat yang berlaku di apotek Pihak Kedua. ~~Apabila Layanan Kesehatan yang diberikan adalah berkenaan dengan pemberian obat kepada Peserta, maka Para Pihak setuju untuk memberlakukan ketentuan mengenai harga obat yang diberikan kepada Peserta adalah harga yang sesuai dengan harga yang diberikan oleh apotek Pihak Kedua kepada pasien umum.~~
- (7) Semua Peserta yang menggunakan Kartu Peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Pihak Kedua dapat dikenakan biaya administrasi oleh Pihak Kedua sebagaimana tercantum pada Lampiran 1D.
- (8) Tata cara pelaksanaan Layanan Kesehatan yang terkait dengan penagihan biaya Layanan Kesehatan kepada Pihak Pertama akan mengikuti persyaratan serta ketentuan yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama dan TPA atau Allianz-TPA serta hanya berlaku dan mengikat bagi Para Pihak apabila segala perubahan tata cara pelaksanaan Layanan Kesehatan dan penagihan tersebut diterima dengan baik oleh Para Pihak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya ketentuan yang baru.
- (9) Dalam hal terjadi perselisihan atau permasalahan antara Pihak Pertama dengan Peserta dan/atau TPA dan/atau dengan pihak lain sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini (terutama bagian manfaat asuransi, klaim yang ditanggung oleh Pihak Pertama, dan hal lainnya yang berkaitan dengan manfaat asuransi), maka Pihak Pertama bertanggung jawab untuk menyelesaikannya tanpa melibatkan Pihak Kedua, namun, Pihak Kedua akan tetap membantu memberikan data dan/atau informasi terkait Layanan Kesehatan yang diberikan kepada Peserta jika diperlukan.
- (10) Dalam hal terjadi perselisihan atau permasalahan antara Pihak Kedua dengan Peserta dan/atau pihak lainnya yang berkepentingan yang berkaitan dengan Layanan Kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua (termasuk pelayanan selama berada di Fasilitas Kesehatan), maka Pihak Kedua bertanggung jawab untuk menyelesaikannya tanpa melibatkan Pihak Pertama.
- (11) COB BPJS Kesehatan.

***Masing-masing Pihak telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dengan demikian ketentuan mengenai COB BPJS Kesehatan akan diberlakukan untuk Peserta yang terdaftar juga sebagai Peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan Peraturan Terkait COB BPJS Kesehatan. Dalam hal diperlukan, Para Pihak dapat mengubah Perjanjian ini untuk memasukan prosedur yang disepakati mengenai pelaksanaan COB BPJS Kesehatan.**

****Masing-masing Pihak telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dengan demikian ketentuan mengenai COB BPJS Kesehatan akan diberlakukan untuk Peserta yang terdaftar juga sebagai Peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan Peraturan Terkait COB BPJS Kesehatan setelah Pihak Kedua menyampaikan pemberitahuan kesiapan pelayanan COB BPJS Kesehatan oleh Fasilitas Kesehatan. Dalam hal diperlukan, Para Pihak dapat mengubah Perjanjian ini untuk memasukan prosedur yang disepakati mengenai pelaksanaan COB BPJS Kesehatan.**

***Pihak Kedua akan segera memberitahukan kepada Pihak Pertama dalam hal Pihak Kedua telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sehingga dapat memberikan layanan COB BPJS Kesehatan sesuai dengan Peraturan Terkait COB BPJS Kesehatan kepada Peserta yang sekaligus juga sebagai Peserta BPJS Kesehatan. Dalam hal diperlukan, Para Pihak dapat mengubah Perjanjian ini untuk memasukan prosedur yang disepakati mengenai pelaksanaan COB BPJS Kesehatan.

II. LINGKUP LAYANAN KESEHATAN

- a. Rawat Inap, termasuk:
 - Tindakan Pembedahan;
 - Perawatan Unit Gawat Darurat dan Ambulans;
 - Perawatan Unit *Day Care*.
- b. Persalinan.
- c. Rawat Jalan Dokter Umum dan Rawat Jalan Dokter Spesialis, termasuk:
 - pemeriksaan diagnostik;
 - obat;
 - imunisasi dasar untuk bayi yang berusia maksimal 1 (satu) tahun, sebagai berikut:
 - (i) DPT 3X (tiga kali);
 - (ii) Polio 3X (tiga kali);
 - (iii) Campak 1X (satu kali);
 - (iv) HIB 3X (tiga kali);
 - imunisasi Hepatitis B 3X (tiga kali) untuk anak yang berusia di bawah lima tahun;
 - pelayanan Keluarga Berencana (KB).
- d. Rawat Jalan Dokter Gigi, yaitu:
 - Perawatan gigi pencegahan, termasuk pembersihan karang gigi sebanyak-banyaknya 2X (dua kali) kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
 - Perawatan gigi dasar, termasuk penambalan gigi dengan amalgam, composite, glass ionomer, compomer baik dengan atau tanpa light curing, penambalan gigi sementara, pemolesan setelah penambalan gigi, pencabutan gigi (tanpa pembedahan), rontgen gigi Dental dan Panoramik (untuk Odontektomi), perawatan periodontal (dengan kuretase), perawatan syaraf (saluran akar gigi), pengobatan infeksi (seperti abses, periodontitis, operculitis, gingivitis) secara intra oral.
 - Perawatan gigi kompleks, termasuk di dalamnya pencabutan gigi (dengan pembedahan dan pembiusan lokal), termasuk odontektomi dan operculectomy, perawatan abses dengan pembedahan dan apeks reseksi.
- e. Telemedicine

III. PENGECUALIAN LAYANAN KESEHATAN

Pihak Pertama tidak menjamin Layanan Kesehatan sebagai berikut:

1. Kelainan bawaan.
2. Perawatan dan/ atau pengobatan yang berkaitan dengan kesehatan mental, perawatan kecanduan obat dan/ atau alkohol, pengobatan psikiatri dan pengobatan-pengobatan yang berkaitan dengan psikolog.
3. Medical check up, kecuali Peserta tersebut memiliki manfaat Medical check up secara cashless.
4. Transplantasi organ tubuh.
5. Perawatan dan atau pengobatan untuk kegemukan, mengurangi berat badan, atau upaya menambah berat badan.
6. Perawatan dan/ atau pengobatan yang berkaitan dengan kosmetik.
7. Perawatan dan/ atau pengobatan yang berkaitan dengan HIV/ AIDS dan penyakit menular seksual.
8. Perawatan dan / atau pengobatan akibat:
 - a. Terlibat aktif dalam perang, kerusakan, perkelahian atau perbuatan kejahatan.
 - b. Luka yang disengaja serta percobaan bunuh diri.
9. Infertilitas yang berhubungan dengan keinginan pasien untuk memiliki keturunan.
10. Setiap Layanan Kesehatan, perawatan dan/atau pengobatan yang tidak Perlu Secara Medis dan/atau dikecualikan dalam Polis yang diterbitkan Pihak Pertama untuk Peserta yang bersangkutan.

LAMPIRAN 1B
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
(LINGKUP LAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN)

(1) Hak-hak Pihak Kedua:

- a. Mendapatkan konfirmasi sehubungan dengan Layanan Kesehatan atas diri Peserta yang Perlu Secara Medis untuk mendapatkan perawatan Rawat Inap di Fasilitas Kesehatan, berikut Formulir Klaim Rawat Inap dari TPA atau nomor persetujuan Rawat Inap dari Allianz-TPA (yang mana yang sesuai dengan konteks dan kasusnya) sebagai jawabannya.
- b. Menerima pembayaran biaya tagihan Layanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

(2) Kewajiban-kewajiban Pihak Kedua:

- a. Memberikan Layanan Kesehatan terbaik kepada Peserta apabila Perlu Secara Medis sesuai dengan jenis dan kelas perawatan yang menjadi haknya. Apabila Layanan Kesehatan tersebut tidak dapat diberikan sehubungan dengan keterbatasan fasilitas Pihak Kedua, maka Pihak Kedua wajib secara seketika memberitahukannya kepada TPA atau Allianz-TPA untuk mencari penyelesaiannya. Keputusan yang berkenaan dengan hal tersebut secara sepenuhnya berada pada TPA atau Allianz-TPA, di mana Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan alternatif penyelesaian.
- b. Menerbitkan Buku Tarif, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam bentuk excel sheet (*e-tariff book*), dan menyerahkannya kepada Pihak Pertama sebagai dasar dalam menentukan biaya tarif yang ditagihkan atas Layanan Kesehatan yang diberikan kepada Peserta. Sebelum menerbitkan Buku Tarif, persetujuan dari Pihak Pertama harus diperoleh terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
- c. Memberikan Layanan Kesehatan kepada Peserta yang sama dengan pasien biasa lainnya dengan tidak membedakan tingkat pelayanannya.
- d. Menjamin bahwa tidak akan ada perbedaan tarif dan layanan antara pasien yang tidak memiliki asuransi kesehatan (non-asuransi) dan Peserta. Segala Layanan Kesehatan dan tarif Layanan Kesehatan akan dilakukan tanpa membedakan status asuransi peserta. Pihak Kedua wajib memberlakukan kebijakan tarif yang adil dan setara bagi semua pasien, tanpa diskriminasi berdasarkan keberadaan atau jenis asuransi.
- e. Melakukan validasi kartu/pemeriksaan awal atas keabsahan Kartu Peserta pada infrastruktur yang disediakan oleh TPA, jika Peserta memiliki fasilitas TPA.
- f. Menghubungi TPA atau Allianz-TPA untuk konfirmasi penjaminan atas perawatan peserta yang Perlu Secara Medis untuk mendapatkan layanan Rawat Inap, kecuali untuk keadaan gawat darurat, Rawat Jalan Dokter Umum, Rawat Jalan Dokter Spesialis dan Rawat Jalan Gigi.
- g. Menjamin dan memastikan bahwa setiap rekomendasi Rawat Inap yang diterbitkan oleh Pihak Kedua (termasuk Dokter) harus disertai dengan indikasi medis yang lengkap, jelas dan sesuai.
- h. Mengisi dan melengkapi Formulir Klaim dengan tulisan yang dapat terbaca dengan jelas, benar dan lengkap berdasarkan Surat Kuasa (terlampir), dan juga memberikan keterangan medis yang benar dan lengkap untuk konfirmasi klaim Peserta.
- i. Memastikan pengisian formulir dengan lengkap, sebenar-benarnya sesuai kondisi medis dan riwayat kesehatan Peserta sebelumnya, serta pengobatan dan pemeriksaan yang sudah dijalani.
- j. Membebaskan biaya kepada Pihak Pertama sesuai dengan kelas perawatan yang menjadi hak Peserta sesuai dengan yang tercantum pada Kartu Peserta, Formulir Klaim Rawat Inap, atau dengan mengacu kepada tarif yang telah disepakati dalam Buku Tarif.
- k. Menagih kelebihan biaya (*excess charge*) secara langsung kepada Peserta apabila (1) Peserta memilih kelas perawatan yang lebih tinggi dari pada haknya sesuai yang tercantum dalam Kartu Peserta atau Formulir Klaim Rawat Inap; (2) Peserta menggunakan hak Layanan Kesehatan, baik Rawat Inap maupun Rawat Jalan, yang melebihi nilai manfaat yang berhak diterima oleh Peserta, atau melebihi nilai yang telah dikonfirmasi dari TPA atau Allianz-TPA; dan/atau (3) Layanan Kesehatan yang diterima oleh Peserta termasuk dalam kategori yang dikecualikan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- l. Melakukan penagihan langsung biaya atas Layanan Kesehatan (termasuk Rawat Inap) kepada Peserta apabila:
 - nomor persetujuan dari Allianz-TPA atau Formulir Klaim Rawat Inap dari TPA dinyatakan batal atau tidak berlaku karena penyakit yang diderita oleh Peserta termasuk yang dikecualikan dalam Perjanjian ini atau Polis Peserta;
 - Pihak Kedua lalai/melakukan kesalahan dalam memasukkan data Peserta, baik mengenai nama penyakit maupun biaya perawatan, yang mengakibatkan klaim menjadi tidak dapat dibayarkan oleh Pihak Pertama; dan/atau
 - Biaya Layanan Kesehatan Rawat Inap Peserta melebihi batas maksimum manfaat sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini.
- m. Menyediakan Layanan Kesehatan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada memastikan bahwa perawatan yang diberikan Perlu Secara Medis, dan bukan untuk pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) dan/atau perawatan atas permintaan Peserta, dengan tetap menjaga mutu pelayanan dan/atau perawatan yang diberikan kepada Peserta.

- n. Menolak Peserta dalam hal:
 - (i) Peserta tidak dapat menunjukkan bukti kepesertaan yang sah berupa Kartu Peserta yang diterbitkan oleh Pihak Pertama, kecuali apabila Pihak Kedua telah mendapatkan konfirmasi sebelumnya dari Pihak Pertama dan/atau TPA atau Allianz-TPA mengenai kepesertaan Peserta;
 - (ii) Pihak Kedua telah diberitahukan secara tertulis bahwa kepesertaan Peserta dalam program asuransi Pihak Pertama telah dihentikan, atau sedang dihentikan untuk sementara waktu;
 - (iii) Peserta tidak bersedia menandatangani Formulir Klaim yang dipersyaratkan;
 - (iv) Peserta dan/atau pihak lainnya meminta Pihak Kedua untuk mengubah tanggal perawatan, diagnosa medis; dan/ atau informasi apapun yang akan diserahkan kepada Pihak Pertama dan/atau TPA atau Allianz-TPA;
 - (v) Peserta berinisiatif meminta Layanan Kesehatan yang tidak Perlu Secara Medis atau tidak berhubungan dengan perawatan yang harus dijalani, seperti tes laboratorium dan tes diagnostik; dan/atau
 - (vi) Peserta meminta Layanan Kesehatan diberikan kepada orang lain yang namanya tidak tertulis pada Kartu Peserta ataupun Formulir Klaim Rawat Inap.
- o. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Peserta meninggalkan Fasilitas Kesehatan, Pihak Kedua wajib mengajukan klaim Rawat Jalan dan klaim Rawat Inap kepada TPA atau Allianz-TPA untuk seluruh biaya tagihan Layanan Kesehatan. Pengajuan klaim harus dilengkapi dengan dokumen penagihan klaim, termasuk Formulir Klaim yang telah diisi dan ditandatangani oleh Peserta, serta Dokter yang merawat, termasuk Dokter yang melakukan tindakan pembedahan jika ada. Pihak Kedua juga harus mengirimkan softcopy tagihan dalam bentuk lembar excel (e-billing) kepada Pihak Pertama. Keterlambatan dalam pengiriman tagihan akan mengakibatkan klaim menjadi kadaluarsa.
- p. Melaksanakan rekomendasi dari Pihak Pertama sehubungan dengan hasil pengkajian/peninjauan berkala.
- q. Menyediakan setiap bantuan dan/atau informasi yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama dalam rangka proses pengurusan dan/atau investigasi klaim Peserta, termasuk tetapi tidak terbatas pada memberikan Laporan Medis Lanjutan (LML), laporan medis Dokter yang merawat/dokter yang ditunjuk oleh Pihak Kedua (Form APS), keterangan medis dan/atau informasi kesehatan Peserta lainnya. Hal ini mencakup informasi klaim Peserta yang diajukan saat itu maupun informasi lainnya terkait dengan Peserta yang dimiliki oleh Pihak Kedua.
- r. Jika Peserta memenuhi syarat untuk menerima "Manfaat Pendamping" (sesuai konfirmasi yang diberikan oleh Pihak Pertama atau TPA), memastikan bahwa pemberian makanan dan/atau penyediaan tempat tidur tambahan bagi pendamping hanya berlaku untuk 1 (satu) orang pendamping, dan jumlah makanan yang disediakan oleh Pihak Kedua harus wajar (tidak berlebihan). Pihak Kedua juga harus memberikan rincian informasi mengenai tagihan terkait dengan penyediaan "Manfaat Pendamping" tersebut.
- s. Memastikan pemberian Layanan Kesehatan dan obat kepada Peserta sesuai dengan ketentuan Perlu Secara Medis, dengan memperhatikan jumlah yang wajar dan biaya yang efektif dan efisien.
- t. Tidak melakukan promosi, *campaign* atau bentuk kegiatan lainnya terkait dengan kelas dan/atau harga pada kamar kepada Peserta yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan harga kamar yang sudah disepakati oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini. Hal ini bertujuan untuk menghindari situasi di mana Peserta yang sebelumnya tidak berhak untuk mendapatkan kamar yang dipromosikan tersebut menjadi berhak atau memenuhi syarat.
- u. Tidak memberikan fasilitas kenaikan kelas kamar kepada Peserta tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama.
- v. Tidak memberikan, bernegosiasi, atau menawarkan insentif apa pun kepada tenaga pemasar, termasuk namun tidak terbatas pada staf Pihak Pertama, baik dalam bentuk uang atau bentuk lainnya, dengan tujuan untuk mereferensikan Peserta Pihak Pertama agar menerima perawatan dan Layanan Kesehatan di Pihak Kedua.
- w. Menjamin dan memastikan bahwa salinan informasi kesehatan untuk suatu Peserta yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah benar, akurat, lengkap dan tidak memiliki perbedaan dengan informasi kesehatan internal Peserta yang dimiliki atau dikelola oleh Pihak Kedua, sehingga Pihak Pertama tidak akan menerima salinan informasi kesehatan tambahan dari Pihak Kedua.
- x. Sehubungan dengan Pemantauan Harian, memberikan informasi sehubungan dengan tagihan harian dan perkembangan kondisi medis Peserta yang sedang menjalani perawatan.
- y. Tidak memberikan atau menawarkan insentif apa pun kepada TPA dalam bentuk uang atau bentuk lainnya, yang terkait dengan Layanan Kesehatan yang diterima oleh Peserta.
- z. Menyediakan Layanan Kesehatan/perawatan sesuai dengan diagnosa dan kondisi medis Peserta termasuk namun tidak terbatas pada Clinical Pathway yang telah disepakati oleh Para Pihak.
- â. Pihak Kedua akan bertanggung jawab dan akan memberikan ganti rugi kepada Pihak Pertama dan masing-masing dari para karyawan, pegawai, direktur, agen, dan perwakilan dari Pihak Pertama dan para pihak ketiga mendapatkan ganti rugi terhadap setiap tanggung jawab,

kehilangan, kerugian, tuntutan, tindakan, biaya atau gugatan yang bersifat apapun (termasuk semua biaya pengadilan dan biaya atau pengeluaran untuk konsultasi hukum), baik yang timbul setelah berlakunya Perjanjian ini atau setelah berakhirnya Perjanjian, yang pada setiap waktu dapat diderita atau timbul secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari atau terkait dengan (i) pengoperasian, administrasi dan/atau pengurusan Rumah Sakit oleh Pihak Kedua, (ii) kelalaian Pihak Kedua, pegawai, atau wakil Pihak Kedua dalam melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan/atau (iii) pelanggaran yang dilakukan Pihak Kedua terhadap ketentuan Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- ä. Kewajiban lainnya yang berlaku bagi Pihak Kedua yang berkaitan dengan pelaksanaan Layanan Kesehatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.

LAMPIRAN 1C
TATA CARA PENERIMAAN PASIEN DAN TATA CARA PENAGIHAN
(LINGKUP LAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN)

A. Tata Cara Pelaksanaan Layanan Kesehatan

No.	Prosedur	Keterangan	PIC/TAT
1.	Memeriksa keabsahan Kartu Peserta dan mencocokkannya dengan bukti identitas diri Peserta yang masih berlaku, dan dilakukan dokumentasi dalam bentuk foto. Menolak proses lebih lanjut dan menolak penyediaan Layanan Kesehatan jika terjadi ketidakcocokan atau ketidaksesuaian.	Bukti identitas Peserta: - Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Surat Izin Mengemudi (SIM) - Paspor	PIC: Pihak Kedua
2.	Melakukan penyimpanan rekam medis dari riwayat kesehatan Peserta sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.	Jangka waktu penyimpanan minimal selama 25 tahun sejak pasien keluar dari Rumah Sakit.	PIC: Pihak Kedua
3.	Memastikan Peserta hanya menggunakan 1 (satu) nomor rekam medis di Pihak Kedua.	Pihak Kedua wajib memastikan bahwa Peserta hanya memiliki 1 (satu) nomor identitas dan rekam medis sehingga tidak ada Peserta yang memiliki lebih dari 1 (satu) nomor identitas dan rekam medis di Pihak Kedua.	PIC: Pihak Kedua
4.	Penyimpanan nama Peserta harus sesuai dengan nama yang tertera pada dokumen identitas Peserta, seperti: - Kartu Tanda Penduduk (KTP) (untuk Peserta dewasa); - Kartu Identitas Anak (KIA) (untuk Peserta anak); dan - Paspor (untuk warga negara asing).	Pihak Kedua wajib memastikan nama Peserta yang terdaftar pada Pihak Kedua sesuai dengan nama yang tercantum pada dokumen identitas KTP (untuk WNI Dewasa), KIA (untuk WNI anak-anak) dan Paspor (untuk WNA).	PIC: Pihak Kedua
Rawat Jalan (termasuk rawat gigi dan optik)			
2a.	Apabila diperlukan, Pihak Kedua dapat mengkonfirmasi kepesertaan Peserta kepada TPA atau Allianz-TPA sesuai dengan jenis Kartu Peserta.	Kontak yang dapat dihubungi oleh Pihak Kedua (sesuai dengan informasi pada Kartu Peserta): 1. <u>Allianz-TPA</u> Telp.: 1500 136 E-mail: azlife-ebmedicalhotline@allianz.co.id 2. <u>Allianz-AdMedika</u> Telp.: 1500 126 E-mail: allianz@admedika.co.id 3. <u>Allianz-Halodoc</u> Telp.: 021 39506663 E-mail: cs.tpa@halodoc.com	PIC: Pihak Kedua
2b.	Menyediakan Formulir Klaim untuk dilengkapi dan ditandatangani oleh Peserta.	Formulir Klaim	PIC: Pihak Kedua
2c.	TPA atau Allianz-TPA akan memberikan konfirmasi kepada Pihak Kedua.		PIC: TPA atau Allianz-TPA
2d.	Memberikan Layanan Kesehatan Rawat Jalan, termasuk rawat gigi dan optik kepada Peserta.		PIC: Pihak Kedua
2e.	Biaya Layanan Kesehatan Rawat Jalan dibayarkan oleh Pihak Pertama atau Allianz-TPA	Sesuai dengan informasi pada Kartu Peserta: 1. <u>Pihak Pertama</u> Seluruh biaya Layanan Kesehatan Rawat Jalan akan dibayarkan dahulu oleh Allianz sesuai hak Peserta.	PIC: TPA atau Allianz-TPA

		2. <u>Allianz-TPA</u> Pihak Kedua akan menginput data untuk kode diagnosa dan biaya (konsultasi Dokter, Obat & Laboratorium). Apabila terjadi eksekusi klaim yang disebabkan oleh manfaat Peserta, maka akan dibayarkan langsung oleh Peserta di lokasi Pihak Kedua, kecuali terdapat ketentuan bahwa eksekusi klaim dijamin dahulu oleh Pihak Pertama.	
Rawat Inap (termasuk Persalinan)			
3a.	Wajib mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada TPA atau Allianz-TPA melalui nomor telepon <i>hotline service</i> yang tercantum pada kolom keterangan nomor 2a dalam hal Peserta memerlukan Layanan Kesehatan yang Perlu Secara Medis untuk di Rawat Inap dengan memberikan diagnosa, Laporan Medis Awal (LMA), hasil pemeriksaan penunjang medis dan/atau dokumen lainnya apabila dibutuhkan oleh TPA atau Allianz-TPA untuk kemudian memperoleh nomor persetujuan Rawat Inap dari TPA atau Allianz-TPA.	- Dalam hal Peserta dirujuk oleh Dokter yang merawat sebelumnya, Pihak Kedua wajib melaporkannya kepada TPA atau Allianz-TPA. Apabila Peserta tidak dapat menunjukkan diagnosa dan Surat Rujukan dari Dokter yang merawat, maka Pihak Kedua dapat melakukan pemeriksaan ulang guna mendapatkan indikasi medis dalam menentukan Rawat Inap Peserta. Pihak Kedua wajib melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada TPA atau Allianz-TPA guna mendapatkan nomor persetujuan Rawat Inap. - Khusus untuk keadaan gawat darurat, Pihak Kedua wajib memberikan pertolongan dan perawatan terlebih dahulu kepada Peserta dan kemudian menghubungi (sesuai dengan informasi yang tercantum pada Kartu Peserta): 1. <u>Pihak Pertama</u> Pihak Kedua akan memperoleh nomor persetujuan Rawat Inap dari Allianz; 2. <u>Allianz-TPA</u> Pihak Kedua akan memperoleh surat jaminan.	PIC: - Pihak Kedua - TPA atau Allianz-TPA TAT: 1x24 Jam
		- Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mewajibkan Peserta membayar uang muka dan/atau pembayaran apapun di awal, dalam menyediakan Layanan Kesehatan Rawat Inap.	
3b.	Menyediakan Formulir Klaim untuk dilengkapi dan ditandatangani oleh Peserta.	Formulir Klaim	PIC: Pihak Kedua
3c.	TPA atau Allianz-TPA akan menerbitkan Surat Jaminan Awal kepada Pihak Kedua setelah seluruh dokumen/informasi yang disebutkan pada nomor 3a dianggap lengkap dan sesuai.	Surat Jaminan Awal yang tercantum nomor persetujuan Rawat Inap.	PIC: TPA atau Allianz-TPA
3d.	Memberikan Layanan Kesehatan Rawat Inap sesuai dengan konfirmasi yang diberikan oleh TPA atau Allianz-TPA.	- Peserta yang Perlu Secara Medis untuk mendapatkan Layanan Kesehatan berupa Rawat Inap, akan ditempatkan pada kelas perawatan yang tidak melebihi batas maksimum biaya atau kelas perawatan sesuai dengan manfaat Peserta.	PIC: Pihak Kedua

		Dalam hal Peserta meminta, atau harus ditempatkan pada kelas perawatan yang lebih tinggi dari manfaat Peserta, maka Pihak Kedua wajib untuk menjelaskan terlebih dahulu kepada Peserta mengenai akses klaim yang akan timbul serta mengkonfirmasi terlebih dahulu atas hal tersebut kepada TPA atau Allianz-TPA.	
3e.	Melakukan <i>daily monitoring</i> sampai dengan selesai Rawat Inap.	Monitoring terhadap perkembangan kondisi kesehatan peserta, billing dan dokumen pendukung lainnya.	PIC: - Pihak Kedua - Pihak Pertama dan/atau TPA atau Allianz-TPA
3f.	Menerbitkan surat jaminan akhir sesuai dengan manfaat, ketentuan & pengecualian polis asuransi Peserta.	Apabila terdapat akses klaim yang disebabkan oleh manfaat Peserta, Pihak Kedua akan menagihkannya langsung kepada Peserta pada saat Peserta pulang, kecuali terdapat ketentuan bahwa akses klaim dijamin dahulu oleh Allianz.	PIC: TPA atau Allianz-TPA

B. Tata Cara Penagihan

No.	Prosedur	Keterangan	PIC/TAT
1.	Mengirimkan Dokumen Penagihan Layanan Kesehatan ke alamat yang tercantum pada Lampiran 1E sesuai dengan kelas perawatan sebagaimana tercantum dalam Kartu Peserta, Buku Tarif yang telah disepakati, atau Surat Jaminan Akhir.	Dokumen Penagihan: - Formulir Klaim - Kuitansi: - Kuitansi asli (bermeterai cukup) berikut perincian biaya perawatan. - Khusus untuk telemedicine, kuitansi asli (bermeterai cukup) berikut perincian biaya perawatan serta cap telemedicine pada dokumen. <u>Catatan:</u> - Memastikan hanya menerbitkan 1 (satu) kali kuitansi perawatan asli dan mudah diidentifikasi/dibedakan dengan kuitansi duplikat atau palsu dengan template 1 (satu) format untuk semua unit. - Salinan kuitansi legalisir hanya dapat diberikan maksimal 2 (dua) kali oleh Pihak Kedua. - Dokumen pendukung selama peserta mendapatkan Layanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang tercantum dibawah ini, namun tidak terbatas pada: - Surat Rujukan; - Salinan resep; - Salinan hasil laboratorium; - Salinan hasil diagnostik; - Salinan ringkasan catatan Medis.	PIC: Pihak Kedua TAT: 30 hari kerja

2.	Meneliti dan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas kelengkapan Dokumen Penagihan yang telah dikirimkan oleh Pihak Kedua.	- Dalam hal Peserta diperlakukan sebagai Pasien umum, Dokumen Penagihan akan dikembalikan kepada Pihak Kedua untuk ditagihkan langsung kepada Peserta.	PIC: Pihak Pertama dan/atau TPA atau Allianz-TPA
		- Dalam hal tagihan untuk jenis Layanan Kesehatan merujuk pada Buku Tarif baru dan pemberlakuan tersebut merupakan bagian dari perubahan Buku Tarif yang belum diberitahukan kepada, dan disetujui oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak untuk membayar tagihan Pihak Kedua berdasarkan Buku Tarif atau Tarif Yang Disepakati yang telah disepakati sebelumnya.	
		- Dalam hal tagihan untuk jenis Layanan Kesehatan yang tidak tercantum dalam Tarif Yang Disepakati, maka tagihan akan mengacu kepada Buku Tarif.	
		- Dalam hal jenis Layanan Kesehatan tidak terdapat dalam Buku Tarif, jenis dan biaya Layanan Kesehatan tersebut harus disepakati secara bersama oleh Para Pihak secara tertulis. Jika tidak ada kesepakatan tersebut, Pihak Pertama untuk tidak membayar biaya yang timbul sehubungan dengan Layanan Kesehatan tersebut.	
		- Ekses klaim yang disebabkan oleh biaya Layanan Kesehatan yang tidak merujuk pada Buku Tarif atau Tarif Yang Disepakati akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.	
3a.	Dalam hal terdapat kekurangan dokumen, TPA atau Allianz-TPA akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pihak Kedua agar melengkapi dokumen yang masih kurang sejak menerima Dokumen Penagihan dari Pihak Kedua.		PIC: TPA atau Allianz-TPA TAT: 14 hari kerja
3b.	Melengkapi kekurangan dokumen setelah menerima surat pemberitahuan dari TPA atau Allianz-TPA.	Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi dalam waktu 14 hari kerja, maka Pihak Pertama dibebaskan dari kewajiban untuk membayar tagihan klaim dari Pihak Kedua dan mengembalikan seluruh berkas tagihan klaim kepada Pihak Kedua. Pihak Kedua selanjutnya tidak dapat melakukan tagihan secara langsung kepada Peserta atas klaim yang tidak dapat dibayarkan Pihak Pertama tersebut.	PIC: Pihak Kedua TAT: 14 hari kerja
4a.	Klaim-klaim yang menurut Pihak Pertama memerlukan penjelasan medis lebih lanjut, akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak	(i) pertanyaan akan diajukan oleh Pihak Pertama setelah dokumen Penagihan diterima oleh TPA atau Allianz-TPA;	PIC: TPA atau Allianz-TPA TAT: 14 hari kerja

	dengan prosedur yang tercantum pada kolom keterangan.	(ii) pertanyaan harus dijawab oleh Pihak Kedua setelah pertanyaan diterima; dan	PIC: Pihak Kedua TAT: 14 hari kerja
4b.	Apabila dalam batas waktu di atas, Para Pihak tidak dapat mencapai kata sepakat atas klaim yang memerlukan penjelasan medis lanjutan, maka Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju bahwa klaim tersebut akan diputuskan oleh Penasehat Medis yang memiliki keahlian khusus atas klaim medis tersebut.	Keputusan Penasehat Medis harus diambil dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berkas klaim diterima dari TPA atau Allianz-TPA, dan akan berlaku dan mengikat Para Pihak dalam Perjanjian ini.	PIC: TPA atau Allianz-TPA dan Pihak Kedua. TAT: 30 hari kerja
5.	Setelah penelitian dan pemeriksaan selesai dilakukan, serta dokumen penagihan dianggap benar dan lengkap, Pihak Pertama dan/atau TPA atau Allianz-TPA akan melakukan pembayaran atas tagihan Layanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pihak Kedua.	Pihak Pertama berhak untuk menolak membayarkan tagihan jika dalam pemberian Layanan Kesehatan terbukti telah dilakukan untuk orang lain yang bukan Peserta dari Pihak Pertama.	PIC: TPA atau Allianz-TPA TAT: 21 hari kerja

LAMPIRAN 1Dm
TARIF YANG DISEPAKATI DAN REKENING BANK

I. TARIF KAMAR DAN KONSULTASI

A. Jasa Pemeriksaan

No	Jenis Poli	Tarif Pemeriksaan
1	Poli Umum	Rp. 150.000
2	IGD	Rp. 200.000
3	Gigi Umum	Rp. 190.000
4	Poli Spesialist	Rp. 250.000
5	Poli Gigi Spesialist	Rp. 300.000

B. Tarif Administrasi

No	Administrasi IRNA	Asuransi Swasta Total
1	III	Rp. 300.000
2	II	Rp. 335.000
3	I	Rp. 355.000
4	ICU	Rp. 355.000
5	ISOLASI	Rp. 355.000
6	VIP	Rp. 400.000
7	VVIP	Rp. 420.000

C. Tarif Kamar Rawat Inap

No	Kelas Perawatan	Asuransi Swasta
1	VVIP	
	Viola A	Rp. 1.050.000
	Viola B	Rp. 1.050.000
2	VIP	
	Anggrek	Rp. 810.000
3	Kelas 1	
	Bougenvile	Rp. 510.000
	Jasmine	Rp. 420.750
4	Kelas 2	
	Cempaka A	Rp. 330.000
	Cempaka B	Rp. 330.000
5	Kelas 3	
	Dahlia A	Rp. 240.000
	Dahlia B	Rp. 240.000
	Dahlia C	Rp. 240.000
6	Isolasi	
	Isolasi A (covid)	Rp. 1.200.000
	Isolasi B	Rp. 330.000
	Isolasi T.Negatif	Rp. 1.200.000
7	Perina	
	Perinatologi Level I	Rp. 330.000
	Perinatologi Level II	Rp. 510.000
8	ICU	
	ICU	Rp. 810.000
9	Recovery Room	
	Recovery Room	Rp. 420.000

D. Tarif Visite Rawat Inap

No	Kelas Perawatan	Asuransi Swasta TARIF
VISITE DOKTER SPESIALIS		
1	VVIP	Rp. 300.000
2	VIP	Rp.262.500
3	I	Rp.225.000
4	II	Rp.187.500
5	III	Rp.150.000
6	ICU	Rp.412.500
7	ISOLASI	Rp.450.000

8	ISOLASI COVID	Rp.525.000
9	PERINATOLOGI Lev 1	Rp.150.000
10	PERINATOLOGI Kelas 1 (Lev 2)	Rp.225.000
	PERINATOLOGI Kelas 2 (Lev 2)	Rp.210.000
	PERINATOLOGI Kelas 3 (Lev 2)	Rp.195.000
VISITE DOKTER UMUM		
11	VVIP	Rp.150.000
12	VIP	Rp.112.500
13	I	Rp.97.500
14	II	Rp.75.000
15	III	Rp.60.000
16	ISOLASI	Rp.187.500

a. BIAYA ADMINISTRASI

Rawat Jalan :

Rawat Inap :

Meterai

b. DISKON

% () dari total biaya perawatan Rawat Inap dan Rawat Jalan, diskon dihitung oleh Pihak Pertama.

Catatan Diskon:

- Diskon dihitung sebelum eksekusi klaim Peserta.
- Jika diskon dihitung oleh Pihak Kedua, maka perhitungan diskon wajib dicantumkan pada tagihan dan rekapan tagihan.

c. REKENING BANK

RS PRIMA HUSADA MALANG :

Nama Rekening : PT. Disa Prima Medika
 Alamat : Banjararum Selatan No.3 Mondoroko, Singosari, Malang
 Nomor Rekening : 368 - 3040700
 Nama Bank : PT.Bank Central Asia Tbk
 Cabang : KK Malang - Singosari
 Kode SWIFT/IBAN : CENAIJJA

RS PRIMA HUSADA SUKOREJO:

Nama Rekening : PT. Disa Prima Medika
 Alamat : Banjararum Selatan No.3 Mondoroko, Singosari, Malang
 Nomor Rekening : 144-0055533324
 Nama Bank : PT Bank Mandiri Persero Tbk
 Cabang : KK Malang - Blimbing
 Kode SWIFT/IBAN : BMRIIDJA

LAMPIRAN 1E
KORRESPONDENSI DAN PENGIRIMAN DOKUMEN PENAGIHAN

I. KORRESPONDENSI

- a. Pihak Pertama
 Nama Perusahaan : PT Asuransi Allianz Life Indonesia
 Alamat Perusahaan : World Trade Centre 6 (Mailing Room-Basement)
 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
 U.p. Bagian Provider Relation
 No Telp : 1500 136 (Allianz Care)
 No Fax : 021-29268080
 Contact Person & Bagian : Provider Relation Department
 Email Team provider relation : azlife-ebnetworkprovider@allianz.co.id
- b. Pihak Kedua
 PT. DISA PRIMA MEDIKA
 Alamat : Banjararum Selatan No.7 Mondoroko, Kec.Singosari, Malang
 Up : Endang Susilowati
 HP/WA : (+62) 812 5299 885
 Email : disaprimamedika@gmail.com
- RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
 Alamat : Banjararum Selatan No.7 Mondoroko, Kec.Singosari, Malang
 Up : dr. Nur Mazidah
 Telp : (0341) 458679
 Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
- RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
 Alamat : Jl. Raya Surabaya - Malang No.Km.54, Lemahbang, Kec.
 Sukorejo, Pasuruan
 Up : dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
 Telp : 081315574065
 Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

Contact Person & Bagian

	Nama & No. Telepon (Hp)	Alamat Email
1. Bagian Marketing RSPH Malang	☑ Nur Lailatul Farida, S.Kep.Ns (0811 3507 164)	☑ marketingrsphm@gmail.com
2. Bagian Finance RSPH Malang	☑ Novi Ratnasari, SE (0341) 458679	☑ keuangan@malang.rs-primahusada.com
3. Bagian Marketing RSPH Sukorejo	☑ Fefi Rita Indah Hati, S.Kep.,Ns. (081315574065 / 081357335016)	☑ backupdatamarketingphs@gmail.com
4. Bagian Finance RSPH Sukorejo	☑ Anita Fitria Sari, S.E (085156001411)	☑ keuanganrsphs@gmail.com

II. ALAMAT PENGIRIMAN TAGIHAN LAYANAN KESEHATAN

- a. Untuk tagihan dengan penjaminan melalui Allianz:
 Allianz Document Management Center (ADMC)
 Senin – Jumat, pukul: 08.00 – 17.00 (kecuali hari libur)
 Setiabudi Atrium, Lt. 3 Suite 308 A-309
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan,
 Karet Kuningan Kec. Setiabudi
 Jakarta Selatan 12920
- b. Untuk tagihan dengan penjaminan melalui TPA dapat melalui:

Admedika	Halodoc
PT Administrasi Medika STO Telkom Gambir, Gedung C Lantai 1, Jl. Medan Merdeka Sel. No.12, RT. 11/RW 2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110	PT Media Dokter Investama Jl. HR. Rasuna Said Kav.32-33, Kuningan Jakarta Selatan 12940 Up. Departemen Klaim – Health Service

Up. : Bagian Klaim	
--------------------	--